



FACULTAD DE OBSTETRICIA Y ENFERMERÍA
“HILDA ZORAIDA BACA NEGLIA”
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

PLAN DE TESIS

**NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE LA
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y EL ESTADO NUTRICIONAL
DE LOS LACTANTES MENORES DE 6 MESES QUE ACUDEN AL
SERVICIO DE CRED EN EL C.S. JESÚS MARÍA.2025**

PARA OPTAR

EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA

PRESENTADO POR:

GLADYS RUBY LEON DAVILA
ROSA ALBERTINA MENDOZA ALVAREZ

ASESORA:

MG. EULALIA MARIA CHAHUAS RODRIGUEZ

LIMA – PERÚ

2025

ÍNDICE

Págs.

Portada

Índice

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ¡Error! Marcador no definido.

1.1 Descripción de la situación problemática . ¡Error! Marcador no definido.

1.2 Formulación del problema4

1.3 Objetivos de la investigación4

1.4 Justificación de la investigación5

1.4.1 Importancia de la investigación5

1.4.2 Viabilidad del estudio6

1.5 Limitaciones de estudio7

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO8

2.1 Antecedentes de la investigación8

2.2 Bases teóricas11

2.3 Definición de términos básicos22

CAPÍTULO III: HIPÓTESIS (si las hubiera) Y VARIABLES23

3.1 Formulación de hipótesis principal y derivadas (si las hubiera)23

3.2 Variables y definición operacional23

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA27

4.1 Diseño metodológico27

4.2 Diseño muestral27

4.3 Técnica de recolección de datos28

4.4 Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información30

4.5 Aspectos éticos31

CRONOGRAMA33

PRESUPUESTO34

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS35

ANEXOS41

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la situación problemática:

La lactancia materna exclusiva (LME) es reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS)¹ como una práctica esencial que garantiza el desarrollo físico, cognitivo y emocional de los lactantes, además de reducir la morbilidad infantil. Esta consiste en alimentarlo con leche materna los primeros seis meses de vida, sin incorporar otros líquidos o sólidos. Por ello esta práctica no solo previene de las enfermedades infecciosas y crónicas, sino que también fortalece el vínculo madre-hijo, posicionándose como un pilar irremplazable de las políticas de salud pública global.

En este contexto, UNICEF (2023)² advierte que más de un 50% de los recién nacidos no inicia la lactancia en la primera hora de vida, y únicamente uno de cada dos mantiene la LME hasta el sexto mes. Estas cifras reflejan un grave problema de acceso a información adecuada, sumado a barreras socioculturales y económicas que limitan su adopción.

Las consecuencias son críticas, dado que la interrupción temprana de la LME antes de sus primeros seis meses de vida, incrementa el riesgo de malnutrición en el lactante, ya sea por déficit (desnutrición, anemia) o por exceso (sobrepeso u obesidad), así como el riesgo de padecer enfermedades inmunoprevenibles, alergias y trastornos metabólicos³.

En América, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS)⁴, el 55% de los recién nacidos inicia la lactancia en la primera hora de vida, apenas el 43% mantiene la LME hasta los seis meses. En el Perú, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)⁵ 2024 indica una prevalencia de un 65.9% de lactantes menores de seis meses que reciben LME, en Lima esta cifra desciende a un 56%, evidenciando una brecha significativa en la capital⁶.

A nivel local, el Centro de Salud de Jesús María no escapa a esta realidad. Según registros del servicio de CRED (2025), de 447 lactantes atendidos, solo 256 corresponden a lactantes menores de 6 meses. Durante las rotaciones realizadas en este establecimiento, se observó que muchas madres presentaban desconocimiento sobre técnicas correctas de amamantamiento, manifestado en frases como: "Mi hijo no se llena solo con mi leche", "Me duele amamantar" o "Le doy fórmula para que deje de llorar".

Estas percepciones, sumadas a errores técnicos (como mala sujeción del pezón o posturas inadecuadas), repercuten en el estado nutricional de los lactantes, condicionando un crecimiento subóptimo y mayor vulnerabilidad a enfermedades. Estudios locales confirman que, a mayor conocimiento materno, mejor nutrición del niño; ante ello, la OMS ha establecido patrones de crecimiento que permiten evaluar el estado nutricional de lactantes⁷.

Diversos estudios respaldan esta correlación entre ellos, Salazar et al.⁸ (2021), en su estudio "Asociación entre la adherencia de las madres a la LME y el estado

nutricional de sus hijos, evaluados en tres centros de salud”, demostraron una asociación estadísticamente significativa, respaldando la relevancia de promover prácticas adecuadas de lactancia para mejorar la salud infantil.

Por ello, es importante reconocer que el personal de enfermería cumple un rol fundamental en el monitoreo nutricional y el crecimiento infantil basado en el modelo de Ramona Mercer quien ofrece un marco teórico valioso para guiar intervenciones de enfermería con evidencia, en la promoción de prácticas óptimas de lactancia materna y prevención de trastornos nutricionales⁹.

Por ello, este estudio busca analizar el nivel de conocimiento sobre LME y su asociación con el estado nutricional de los lactantes, para diseñar intervenciones efectivas, identificando así las brechas educativas en las madres para optimizar las estrategias de consejería en salud, además de contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2 y 3), reforzando el derecho del lactante a una alimentación adecuada desde los primeros meses de vida¹⁰.

Considerando lo anterior, se plantea la siguiente interrogante:
¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento de las madres sobre lactancia materna exclusiva y el estado nutricional de los lactantes menores de 6 meses que acuden al servicio de CRED en el Centro de Salud de Jesús María.2025 ?
A partir de lo previamente señalado, se plantea la siguiente problemática.

1.2. Formulación del problema:

¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento de las madres sobre lactancia materna exclusiva y el estado nutricional de los lactantes menores de 6 meses que acuden al servicio de CRED en el Centro de Salud de Jesús María. 2025?

1.3. Objetivos de la investigación:

1.3.1. Objetivo general:

Determinar la relación entre el nivel de conocimiento de las madres sobre lactancia materna exclusiva y el estado nutricional de los lactantes menores de 6 meses atendidos en el servicio de CRED del Centro de Salud de Jesús María. 2025

1.3.2. Objetivos específicos:

- Establecer la relación entre nivel de conocimiento de las madres sobre lactancia materna y el patrón de crecimiento Peso/edad en los lactantes menores de 6 meses.
- Establecer la relación entre nivel de conocimiento de las madres sobre lactancia materna y el patrón del crecimiento Talla/Edad de lactantes menores en lactantes menores de 6 meses.
- Establecer la relación entre nivel de conocimiento de las madres sobre lactancia materna y el patrón de crecimiento Peso/Talla en lactantes menores de 6 meses.

1.4. Justificación de la Investigación:

1.4.1. Importancia de la investigación:

Según el último reporte de UNICEF¹¹ del año 2023, las regiones de América Latina y el Caribe, señalan que sólo el 43% de lactantes menores de seis meses son alimentados exclusivamente con leche materna, siendo esta cifra considerablemente inferior al 70% recomendado por la OMS. Este panorama preocupante, adquiere mayor relevancia al considerar que la LME es vital para garantizar el óptimo crecimiento infantil, fortalecer el sistema inmunológico y promover el neurodesarrollo.

Así mismo es importante destacar que en el Centro de Salud de Jesús María lugar donde se realizará la investigación no existen estudios previos que analicen las variables críticas de la LME, a pesar de que existen múltiples indagaciones que han demostrado su directa correlación con el estado nutricional del infantil.

Esta brecha de conocimiento local justifica el desarrollo del presente trabajo no solo porque generará conocimiento específico sobre las prácticas LME, sino que además permitirá implementar intervenciones educativas mediante talleres participativos con material culturalmente adaptado, así como el seguimiento personalizado y la evaluación sistemática durante el control de CRED estableciendo un precedente para futuras investigaciones e intervenciones en la población infantil.

1.4.2. Viabilidad:

Para la ejecución del estudio se considera que existen condiciones favorables que garantizan su factibilidad, como son: los recursos humanos, compuesta por dos investigadores competentes para realizar las diferentes etapas del proceso investigativo, desde la recolección hasta el análisis de datos.

Otros son, los recursos financieros y materiales, necesarios para la aplicación de las encuestas, procesamiento y análisis de los datos, incluyendo la impresión de instrumentos, papelería, acceso a software estadístico, entre otros insumos será asumido por los investigadores.

Respecto al acceso a información, se dispone de fuentes confiables y actualizadas para respaldar el marco teórico y contextual del estudio, tales como artículos científicos, tesis, investigaciones previas y documentos emitidos por el ente rector (MINSA), además de normas técnicas nacionales e internacionales provenientes de organismos reconocidos como la OMS, OPS y UNICEF.

Otra condición es el tiempo, ya que lo estimado para la ejecución del estudio ha sido planificado cuidadosamente en un cronograma de actividades realista y viable, lo que asegura que las acciones se desarrollarán dentro del plazo establecido (agosto-octubre de 2025).

Por último, no menos importante, están los conocimientos técnicos y metodológicos, con los cuales cuentan los investigadores para aplicar adecuadamente los instrumentos, interpretar los datos obtenidos y elaborar las conclusiones del estudio de manera rigurosa y ética.

1.5. Limitaciones del estudio:

Este estudio reconoce cuatro limitaciones principales: (1) dificultades de localización geográfica de madres, (2) restricciones de tiempo por cargas laborales, (3) potencial sesgo de deseabilidad social, y (4) variabilidad estacional en indicadores nutricionales. Para mitigarlas, se implementarán visitas programadas con flexibilidad horaria, triangulación de fuentes para ubicación, validación objetiva de datos antropométricos y control estricto del periodo de recolección.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación:

INTERNACIONALES

Según, Díaz¹², en Ecuador en el 2022, publicó una investigación sobre “Nivel de conocimiento que tienen las madres de puerperio mediato sobre lactancia materna y su relación con el estado nutricional del recién nacido en el Hospital General San Francisco de Quito”. Es un estudio descriptivo, de enfoque cuali-cuantitativo y transversal, desarrollado con una muestra intencional de 40 madres en puerperio mediato. Se aplicó de manera presencial una encuesta estructurada y validada que abarca todas las variables e indicadores de interés, complementada con observación directa de la práctica de lactancia materna. Entre los resultados se destaca: Los conocimientos de la mayoría de madres según la escala LACH dificultan la lactancia. La pérdida de peso del 82,5% de niños se ubica en el percentil 50 lo que sugiere normalidad.

Asimismo, Méndez¹³ en México en el 2023, publicó una investigación sobre “Conocimiento, práctica correcta del amamantamiento y nutrición en lactantes menores de 6 meses”. Estudio analítico, observacional y transversal, se aplicó la encuesta conocimientos de la lactancia materna, guía de técnica de amamantamiento, curvas de crecimiento infantil de la OMS. La correlación se estimó con Chi cuadrada. En sus resultados Se

incluyeron 214 participantes y se encontró correlación entre el estado nutricional de los lactantes el 74.8% peso normal, el 16.4% sobrepeso y el 0.9% obesidad. El conocimiento de las madres el 59.3% conocimiento bueno. La práctica correcta del amamantamiento el 96.3 % realizaron una adecuada técnica. La relación del conocimiento de las madres sobre el estado nutricional $P = .004$ y la práctica correcta del amamantamiento y el estado nutricional el valor de $P = .001$.

NACIONALES

Cabe mencionar a Salazar et.al⁸, en Chiclayo en el 2021 desarrollaron una investigación, titulada “Asociación entre la adherencia de las madres a la LME y el estado nutricional de sus hijos, evaluados en tres centros de salud”. El método aplicado fue de nivel descriptivo-relacional, con una muestra conformada por 142 madres y 8 lactantes menores de seis meses. Para la recolección de datos se empleó el cuestionario y una lista de chequeo, que permitió evaluar conocimientos sobre lactancia materna y estimar el estado nutricional. Los resultados mostraron una relación significativa entre la LME y el estado nutricional, evidenciándose una significancia estadística de $p=0.007$ en lactantes de entre 1 y 6 meses que acuden a los centros de salud de Mórrope, Salas y Jayanca.

Así mismo, Zapata¹⁴, en 2022, publicó su estudio “Conocimiento sobre lactancia materna en madres y estado nutricional de los niños menores de 6 meses en un centro de salud materno infantil nacional, Trujillo – 2022”. Estudio descriptivo, correlacional; diseño no experimental y trasversal. La

muestra se conformó de 86 madres de niños menores de 6 meses, los cuales asistían con regularidad a un Centro de Salud Materno Infantil de Trujillo. Técnica empleada fue la encuesta (cuestionario de 20 preguntas), en la variable estado nutricional se utilizó la ficha de recolección de datos, instrumento que recolecta información de antropometría (peso y talla), perímetro cefálico, hemoglobina y diagnósticos según la escala de la OMS, CENAN para la evaluación del estado nutricional, y la norma técnica de la anemia (MINSA), se aplicó la prueba estadística de correlación de Ch2. Estos datos obtenidos se procesaron con Excel 2019 y SPSS V-26.0, teniendo como resultado que el 81.4% presentó nivel de conocimiento alto, el 18.6% nivel de conocimiento medio, además se encontró relación significativa entre el nivel de conocimiento sobre lactancia materna en sus dimensiones como: evaluación antropométrica y perímetro cefálico del estado nutricional.

Según Romero¹⁵, en 2023, publicó una investigación sobre “Lactancia materna exclusiva y estado nutricional de niños menores de 6 meses que son atendidos en el consultorio de crecimiento y desarrollo en un centro de salud de Lima, 2023”. La metodología se enmarcó en el método hipotético deductivo, bajo el enfoque cuantitativo, adoptó un tipo de investigación aplicada, con diseño no experimental, de nivel correlacional, la muestra la conformaron 80 madres de infantes de 0 a 6 meses. Por consiguiente, se aplicó el muestreo de tipo probabilístico aleatorio simple. Para recolectar los datos se utilizó la encuesta y el análisis documental. Como instrumentos se utilizó el cuestionario que midió el nivel de conocimiento sobre la lactancia

materna exclusiva a través de 15 ítems y una ficha de registro para la estimación nutricional. El instrumento fue validado tomando en cuenta el contenido contando con la opinión de expertos, la confiabilidad tuvo un valor de 0.7058, la misma se calculó utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach. Los resultados muestran una correlación positiva fuerte media entre la lactancia materna exclusiva y el estado nutricional, obteniendo un valor correlacional de 0,221 según el coeficiente de rangos de Spearman y la significancia fue de $0.049 < 0.05$.

2.2. Bases teóricas:

2.2.1. Nivel de conocimiento: El conocimiento se concibe actualmente como el proceso progresivo, gradual e incremental, desarrollado por el hombre para entender la realidad objetiva que lo rodea. El nivel del mismo, se refiere al grado de comprensión que una persona tiene sobre un tema específico, deriva del avance en la producción del saber, es decir, puede variar desde un conocimiento básico y superficial hasta uno profundo y experto¹⁶.

2.2.2. Conocimiento sobre lactancia materna exclusiva

Se refiere a la información y comprensión que una madre, tiene sobre la composición de la leche materna, sus beneficios nutricionales e inmunológicos para el infante, la técnica de amamantamiento, agarre correcto y frecuencia en su administración.

2.2.3. Lactancia materna Exclusiva: Es un proceso de síntesis y producción de leche, primordial para el cumplimiento de los derechos a la salud de los niños y las niñas para alcanzar un crecimiento y desarrollo óptimos, ya que ofrece beneficios inigualables en la salud física y emocional de los lactantes y sus madres que perdurarán a lo largo de sus vidas¹⁷.

a) La leche materna exclusiva: Se refiere a la práctica de alimentar a un bebé únicamente con leche materna, sin ningún otro alimento o líquido, ni siquiera agua, durante los primeros seis meses de vida. Es el alimento ideal para los lactantes, se inicia durante la primera hora de vida; es segura y limpia.¹⁸.

Además, suministra toda la energía y nutrientes que una criatura necesita durante los primeros meses de vida, y continúa aportando hasta la mitad o más de las necesidades nutricionales de un niño. Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS)¹⁹ propone la lactancia materna como la vacuna más perfecta de todos los tiempos.

b) Etapas²⁰:

- **Calostro:** Fluido lácteo de coloración amarilla y espesa, exudada en mínimas proporciones de 2 a 20 ml por cada toma, durante los primeros cinco días tras el parto. Posee una elevada concentración de elementos inmunoprotectores, y compuestos minerales como el calcio. Su limitada disponibilidad permite al lactante coordinar tres mecanismos esenciales: absorción, deglución y ventilación. Asimismo, favorece la evacuación del meconio, previene la ictericia neonatal y propicia la maduración del aparato digestivo.
- **Leche de transición:** Es la secreción láctea emanada entre el quinto y el decimoquinto día posnatal. Al tercer día se obtiene un incremento súbito en la producción de leche conocido como la “bajada de la leche” razón por el cual las mamas se llenan rápidamente. Su volumen oscila entre 600 y 700 ml/día entre la segunda y cuarta semana tras el parto.
- **Leche madura:** Es la secreción láctea segregado desde el decimosexto día en adelante, con una tonalidad azulada, con un volumen de 700 –

900 ml/día. Al inicio es fluida y liviana, aliviando la sed del lactante, y paulatinamente se torna espesa por el aumento de la grasa y esto se da durante los primeros 6 meses de producido el parto.

c) Composición de la leche materna: Su composición bioactiva impacta la salud gastrointestinal, el sistema inmunológico y el desarrollo cerebral del recién nacido. Evoluciona para cumplir con las necesidades cambiantes del neonato durante el período de lactancia. Desde los primeros días después del parto, el calostro, denominado "oro líquido", actúa como un protector inmunológico crucial para el recién nacido. Este fluido inicial contiene una riqueza de componentes inmunológicos como la IgA secretora, lactoferrina y leucocitos.

A medida que progresa la lactancia, la leche materna exhibe una notable variabilidad en su composición. Al principio, es más acuosa, ideal para satisfacer la sed del recién, y está cargada de proteínas, minerales, vitaminas hidrosolubles y lactosa. Al final del amamantamiento, su aspecto se vuelve más blanco, su contenido de grasa aumenta y se enriquece con vitaminas liposolubles.²¹.

d) Importancia de la leche materna: Es el mejor alimento para el lactante durante los primeros meses de vida, no solo porque cubre las necesidades nutricionales para un adecuado crecimiento y desarrollo físico del bebé, sino que, desde el punto de vista emocional, asegura el establecimiento de un buen vínculo madre-hijo/a y una adecuada relación de apego seguro con su madre, ambos esenciales para un correcto desarrollo como persona independiente y segura. Además, es un recurso renovable y sostenible con demostrados beneficios para la salud tanto del bebé como de la mamá.

Por todo ello la lactancia materna es considerada el método de referencia para la alimentación y crianza del lactante y el niño pequeño. La leche materna es un alimento vivo, adaptado a la edad y condiciones fisiológicas de cada bebé, que aporta nutrientes esenciales y protección frente a enfermedades, estableciéndose una relación muy especial entre cada mamá y su bebé amamantado²².

e) Beneficios de la leche materna²⁰:

Para el lactante:

- Favorece el desarrollo físico y emocional de la o el bebé.
- Protege contra la infección y enfermedades como: gripe, asma, neumonía, alergias, diarreas, etc.
- Genera un mayor coeficiente intelectual.
- Nutrición ideal
- Refuerza el vínculo afectivo madre-niña o niño
- Reduce el riesgo de anemia temprana.
- Promueve la adecuada dentición y el desarrollo del habla.
- Reduce el riesgo de infecciones, desnutrición, alergias e intolerancia a la leche.
- Disminuye el riesgo de algunas enfermedades crónicas y la obesidad.

Para la madre:

- Promueve mayor satisfacción y fortalece la autoestima de la madre.
- Favorece la mejor recuperación fisiológica post parto.
- Contribuye a la disminución del peso y del riesgo de obesidad.
- Reduce la posibilidad de cáncer de ovario y de mama, así como de osteoporosis.

- Le permite proporcionar de manera sencilla un alimento natural, apropiado, ecológico y económico.
- Reduce la ausencia laboral de la madre.

f) Cantidad y frecuencia de lactancia materna

Es importante la higiene antes de iniciar con la lactancia, por ello se debe lavar las manos con agua y jabón. El bebé tiene que realizar tomas muy frecuentes (8-10 tomas diarias). Se debe permitir que el bebé mame hasta que quede satisfecho, y no retirarle del pecho, aunque lleve tiempo en el mismo, es decir a libre demanda.

Se debe amamantar al bebé cada vez que lo pida; al principio, hay bebés que necesitan mamar muy a menudo. Si se le ofrece el pecho y lo acepta es porque lo necesita. Además, nunca hay que olvidar que no sólo se está alimentando al bebé, también se le ofrece consuelo, seguridad, calor y el afecto necesario para su crecimiento y desarrollo.

Hay bebés que se agotan y necesitan pausas para descansar. Hay quienes maman durante 20 minutos y, sin embargo, reciben la misma cantidad que quienes lo hacen durante menos tiempo²³.

h) Agarre correcto para amamantar

Antes de conocer el agarre, es importante saber acerca de los reflejos con el que el bebé nace en búsqueda de alimentación, como es el reflejo de succión, el cual se caracteriza porque el bebé mueve la cabeza y abre la boca para buscar en dirección al seno de la madre. Un agarre correcto en la lactancia materna es fundamental para una experiencia exitosa tanto para la madre como para el bebé. Cuando el niño no tiene un buen agarre, los senos de la madre pueden sufrir grietas o heridas en el pezón.

Es fundamental asegurarse de que el bebé tenga un buen agarre al pezón, lo que significa que abarque gran parte de la areola, no solo el pezón. La madre debe sostener el pecho con la mano en forma de "C", con el pulgar por encima de la areola y los otros dedos por debajo, acercando al bebé al pecho con la boca bien abierta, con la lengua por debajo del pezón. La nariz y el mentón del bebé deben estar en contacto con el pecho, y los labios deben estar evertidos (hacia afuera). Un buen agarre evita dolor en la madre, asegura una succión efectiva y el vaciado completo del pecho²⁴.

i) Técnicas de amamantamiento:

Configuraciones posturales para la alimentación materna²⁰:

- **Postura instintiva:** Se fundamenta en la observación de reflejos primarios en la madre y el recién nacido, activando mecanismos innatos que optimizan el enganche, la eficacia en la toma y la secreción láctea.
- **Postura erguida:** Disponer al infante con el torso encarado y ceñido al materno, sujetándolo por la espalda con una mano mientras la cabeza reposa en el antebrazo. Con la otra extremidad, la madre guía el pecho hacia la cavidad oral del niño y, al percibir que abre la boca, lo acerca suavemente para lograr un acople profundo sobre la aréola.
- **Postura reclinada:** La madre se acomoda en decúbito lateral con la cabeza ligeramente elevada sobre un cojín, mientras el lactante, en igual disposición, se encuentra de cara y adherido al torso materno para favorecer el enganche.
- **Posición de sujeción invertida (balón de rugby):** El lactante se coloca bajo la axila materna con los miembros inferiores dirigidos hacia atrás y

la cabeza alineada con el pecho, situando el pezón a la altura de su nariz. Esta disposición resulta altamente funcional para amamantar a gemelos y prematuros.

- **Postura ecuestre:** La madre permanece sentada mientras el lactante reposa erguido sobre una de sus extremidades inferiores, con el abdomen en contacto y apoyado contra el tronco materno. Es una técnica favorable para casos de fisuras mamarias, reflujo gastroesofágico severo, prematuridad, hendiduras labiales o palatinas, y micrognatia.

2.2.4. Estado nutricional: Es la situación de salud en que se encuentra una persona como resultado de su nutrición, régimen alimentario y estilo de vida²⁵.

- **Riesgo de bajo peso:** Es la probabilidad de padecer desnutrición por bajo peso para la talla.
- **Delgadez:** Es la clasificación de la valoración nutricional antropométrica caracterizada por una insuficiente masa corporal con relación a la talla.
- **Riesgo de sobrepeso:** Es la probabilidad de padecer sobrepeso por exceso de P/T o por exceso de P/E en niñas y niños menores de 5 años.
- **Sobrepeso:** Es la clasificación de la valoración nutricional antropométrica, donde el peso es superior a lo normal. En niñas y niños menores de 5 años, es determinada cuando el valor del indicador P/T o P/E, se encuentra entre >2 DE y a 3 DE.
- **Obesidad:** Es la clasificación de la valoración nutricional antropométrica, donde el peso es excesivamente superior a lo normal. En niñas y niños menores de 5 años, es determinada cuando el valor del indicador P/T es mayor a 3 DE.

- **Desnutrición:** Es el estado patológico, inespecífico, sistémico, potencialmente reversible de un individuo; resultado de la ingesta insuficiente de energía y nutrientes en la dieta, trastornos digestivos, problemas de absorción u otras condiciones médicas. En niñas y niños menores de 5 años es determinado cuando el P/T, P/E o T/E están por debajo de -2 DE.
- **Malnutrición:** Es el estado nutricional anormal causado por la deficiencia o exceso de energía, macronutrientes y/o micronutrientes, incluye la delgadez, sobrepeso, obesidad, anemia, entre otros.

2.2.5. Antropometría: Es el proceso de medición de las dimensiones y algunas características anatómicas del cuerpo, a través de las variables antropométricas como peso, longitud (talla), perímetro cefálico, entre otros²⁵

- **Perímetro cefálico:** Es la medida de la circunferencia de la cabeza que se realiza a toda niña y a todo niño hasta los 36 meses de edad, en su parte más amplia (por encima de las cejas y de las orejas y alrededor de la parte posterior más prominente de la cabeza).
- **Peso:** Es la estimación de la masa corporal de una persona, expresada en kilogramos.
- **Talla:** Es la medida de la longitud o estatura de la persona.

2.2.6. Control de Crecimiento y Desarrollo: Es el conjunto de actividades periódicas y sistemáticas realizadas por el/la profesional de la salud de enfermería y/o médico, con el fin de detectar de forma precoz la presencia de alteraciones o enfermedades, facilitando su diagnóstico e intervención oportuna para disminuir los riesgos²⁵.

➤ **Crecimiento adecuado:** Es la condición en la niña(o) que evidencia ganancia de peso e incremento de talla de acuerdo a los rangos de normalidad esperados para su edad (± 2 Desviación estándar alrededor de la mediana).

➤ **Crecimiento inadecuado:** Es la condición en la niña(o) que evidencia la no ganancia o ganancia mínima de la talla. Cuando la tendencia del crecimiento cambia de carril, es necesario interpretar su significado, pues puede ser un indicador de crecimiento inadecuado o riesgo del crecimiento aun cuando los indicadores P/T o T/E se encuentren dentro de los puntos de corte de normalidad (± 2 Desviación estándar).

2.2.7. CLASIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA DURANTE LA ATENCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS²⁵:

➤ **PESO PARA LA EDAD:** Es el indicador resultante de comparar el peso de la niña o del niño con el peso de referencia correspondiente a su edad, sea en semanas, meses o años; y, que puede identificar desnutrición para una edad específica al compararlo con los datos de referencia. Es sensible para detectar cambios nutricionales en el seguimiento longitudinal de niñas y niños, siempre que se cuente con un número determinado de controles; es útil, preferentemente, dentro de los primeros 6 meses de vida. No debe usarse para clasificar sobrepeso y obesidad.

Clasificación de la niña y del niño menor de 5 años según P/E	
Punto de corte (Desviaciones Estándar)	Peso para la edad
	Clasificación
> 3 DE	Sobrepeso* Normal Bajo peso Bajo peso severo
> 2 DE	
2 DE a -2 DE	
< -2 DE a -3 DE	
< -3 DE	

Fuente: Adaptado de Organización Mundial de la Salud. 2008. Patrones de crecimiento del niño. Curso de capacitación sobre la evaluación del crecimiento del niño. Módulo C: Interpretando indicadores de crecimiento.
DE = Desviación Estándar.
(*) No considerar para intervención, como sobrepeso, a niñas y niños menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva.

- **PESO PARA LA TALLA:** Es el indicador resultante de comparar el peso de la niña o del niño con el peso de referencia correspondiente a su longitud o estatura, refleja el peso corporal alcanzado en proporción a la longitud o estatura, e indica el nivel de reservas calóricas; por lo que, identifica niñas y niños adelgazadas/os o emaciadas/os (desnutrición aguda), o con sobrepeso y obesidad. Al no ser tan sensible el indicador P/E, toda niña y todo niño con peso para talla normal no se considera malnutrida/o cualquiera sea su P/E.

Clasificación de la niña y del niño menor de 5 años según P/T	
Punto de corte (Desviaciones Estándar)	Peso para la talla
	Clasificación
> 3 DE	Obesidad* Sobrepeso* Normal** Bajo peso / Emaciado Bajo peso severo
> 2 DE	
2 DE a -2 DE	
< -2 DE a -3 DE	
< -3 DE	

Fuente: Adaptado de Organización Mundial de la Salud. 2008. Patrones de crecimiento del niño. Curso de capacitación sobre la evaluación del crecimiento del niño. Módulo C: Interpretando indicadores de crecimiento.
DE = Desviación Estándar

- **TALLA PARA LA EDAD:** Es un indicador que refleja el crecimiento lineal alcanzado en longitud o estatura para la edad, resultante de comparar la longitud o estatura de la niña o del niño con la longitud o estatura de referencia correspondiente a su edad. Asimismo, identifica la talla baja (desnutrición crónica) y es un buen indicador del estado nutricional a largo plazo.

Clasificación de la niña y del niño menor de 5 años según T/E	
Punto de corte (Desviaciones Estándar)	Talla para la edad
	Clasificación
> 3 DE	Alto Normal Talla baja Talla baja severa
> 2 DE	
2 DE a -2 DE	
< -2 DE a -3 DE	
< -3 DE	

Fuente: Adaptado de Organización Mundial de la Salud. 2008. Patrones de crecimiento del niño. Curso de capacitación sobre la evaluación del crecimiento del niño. Módulo C: Interpretando indicadores de crecimiento.
DE = Desviación Estándar

3. Definición de términos básicos:

3.3.1. Lactante menor: Menor desde el nacimiento hasta los 11 meses y 29 días de vida ²⁶.

3.3.2. Crecimiento: Fenómeno de expansión de la estructura corporal de un organismo vivo ²⁶.

3.3.3. Desarrollo: Procedimiento evolutivo mediante el cual los seres vivos adquieren gradualmente la capacidad operativa de sus sistemas ²⁶.

3.3.4. CRED: Supervisión del progreso físico y madurativo de la niña(o) ²⁶.

3.3.5. Indicadores antropométricos: Parámetros de tamaño y configuración corporal, entre los más empleados en infantes se encuentran: P/T, P/E, T/E y perímetro cefálico ²⁵.

3.3.6. Enfermera(o): Como profesional de la Ciencia de la Salud, interviene en la prestación de los servicios de salud integral, en forma científica, tecnológica, sistemática y humanista, en los procesos de promoción, prevención recuperación y rehabilitación de la salud, mediante el cuidado de la persona, la familia y la comunidad²⁷.

3.3.7. Consejería: Procedimiento instructivo y comunicativo que tiene como propósito orientar a la madre, padre o responsables del menor²⁴.

CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES

3.1 Formulación de hipótesis principal y derivadas:

Hi: “Existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento de las madres sobre la lactancia materna exclusiva y el estado nutricional de los lactantes menores de 6 meses atendidos en el servicio de CRED del Centro de Salud Jesús María. 2025”.

Ho: “No existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento de las madres sobre la lactancia materna exclusiva y el estado nutricional de los lactantes menores de 6 meses atendidos en el servicio de CRED del Centro de Salud Jesús María. 2025”.

3.2. Variables y definición operacional:

Variable 1: Nivel de conocimiento de las madres sobre lactancia materna exclusiva

Definición conceptual: Es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori) de las madres sobre lactancia materna.

Definición Operacional: Los conocimientos de la madre sobre la lactancia materna exclusiva son importantes para el menor de 6 meses, ya que así ayudará al niño en cuanto su estado nutricional, ello se evaluará con un Cuestionario elaborado por Rodríguez. Se evaluará: Por cada respuesta

correcta se obtiene 1 punto, mientras que por cada incorrecta se obtiene 0, teniendo como puntaje final un rango de 0 a 20. Con el valor final alto (14-20), medio (7-13) y bajo (0-6)²⁸.

Variable 2: Estado nutricional de los lactantes menores de 6 meses

Definición conceptual: Instrumento de medición del estado fisiológico en las etapas de crecimiento y desarrollo, permite el diagnóstico de la desnutrición con el fin de tomar medidas preventivas, curativas, paliativas y rehabilitadoras que favorezcan el bienestar del sujeto.

Definición operacional: Para estimar el estado nutricional en función con la ingesta de nutrientes, se verificará si el crecimiento y desarrollo del lactante presenta deficiencias. Se emplearán Tablas Antropométricas (MINSA), evaluando: P/E, P/T, T/E ²⁵.

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE

V1. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA

VARIABLE	DIMENSIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA
V1. Nivel de conocimiento de las madres sobre la lactancia materna exclusiva	Es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori) de las madres sobre lactancia materna.	Los conocimientos de la madre sobre la lactancia materna exclusiva son importantes para el menor de 6 meses, ya que así ayudará al niño en cuanto su estado nutricional, ello se evaluará con un Cuestionario elaborado por Rodríguez. Se evaluará: Correcto: 1 punto Incorrecto: 0 puntos Alto (14 – 20) Medio (07 – 13) Bajo (0 – 06)	Aspectos generales	Definición de lactancia materna exclusiva	Ordinal Total: Alto (14 – 20) Medio (07 – 13) Bajo (0 – 06) Dimensiones: Aspectos generales: Alto (07 – 09) Medio (04 – 06), Bajo (0 – 03) Técnica de amamantamiento: Alto (08 – 11), Medio (04 – 07), Bajo (0 – 03)
				Inicio temprano de la lactancia materna	
				Importancia de la lactancia materna exclusiva	
				Tipos de leche materna	
				Beneficios de lactancia materna exclusiva	
			Técnica de amamantamiento	Medida de higiene	
				Reflejo de búsqueda (señal) del bebé	
				Posición de la madre	
				Posición del bebé	
				Signos de un buen agarre	
				Signos de una buena succión	
				Signos de una mala succión y/o mal agarre	
				Duración y frecuencia de las mamadas	

V2: ESTADO NUTRICIONAL DE LOS LACTANTES MENORES DE 6 MESES

VARIABLE	DIMENSIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA
V2.-Estado Nutricional de los Lactantes menores de 06 meses	Instrumento de medición del estado fisiológico en las etapas de crecimiento y desarrollo, permite el diagnóstico de la desnutrición con el fin de tomar medidas preventivas, curativas, paliativas y rehabilitadoras que favorezcan el bienestar del sujeto.	Para estimar el estado nutricional en función con la ingesta de nutrientes, se verificará si el crecimiento y desarrollo del lactante presenta deficiencias. Se emplearán Tablas Antropométricas (MINSA), evaluando: Peso/Edad Peso/Talla Talla/Edad.	Peso/ Edad	Sobrepeso Normal Bajo peso Bajo peso severo	Ordinal Peso /Edad >+2 +2a – 2 < -2 a – 3 < -3
			Peso/ Talla	Obesidad Sobrepeso Normal Desnutrición Aguda Desnutrición severa	Peso/Talla >+3 >+2 +2 a -2 <-2 a – 3 < -3
			Talla/ Edad	Muy alto Alto Normal Talla baja Talla baja severa	Talla/ Edad >+3 <+2 +2 a-2 <-2 a -3 <-3

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA

4.1 Diseño Metodológico:

El tipo de investigación realizada según su enfoque es cuantitativo, descriptivo, correlacional de corte transversal, y prospectivo.

4.2 Diseño muestral:

El conjunto poblacional estará conformado por **256 lactantes** que han recibido atención en el servicio de **CRD** del **Centro de Salud de Jesús María. 2025**, conforme a la especificación detallada en la siguiente tabla:

Meses	N° de lactantes atendidos	Porcentajes
Enero	33	12.89%
Febrero	36	14.06%
Marzo	49	19.14%
Abril	51	19.92%
Mayo	44	17.19%
Junio	43	16.80%
Total	256	100%

Fuente: Registro de pacientes atendidos en el servicio de CRED, 2025

Muestra: Para la magnitud muestral se empleará el muestreo probabilístico, esta muestra representa el 59.7% de la población siendo así 153 pacientes que serán seleccionados de forma aleatoria. **(ANEXO F)**

Criterios de Inclusión:

- Madres de lactantes de 0 a 6 meses.
- Madres de lactantes que se atienden en el Centro de Salud de Jesús María.
- Lactantes evaluados por CRED.
- Madres de lactantes con Lactancia Materna Exclusiva.
- Madres que han otorgado su consentimiento informado.

Criterios de Exclusión:

- Madres de niños mayores de 6 meses.
- Madres de lactantes que no se atienden en el Centro de Salud de Jesús María.
- Lactantes no evaluados por CRED.
- Madres que no practican la Lactancia Materna Exclusiva.
- Madres que no han suscrito el consentimiento informado.

4.3 Técnicas de recolección de datos:

4.3.1. Técnicas:

En esta investigación emplearemos la técnica de la encuesta. Esta es una técnica empleada para la recolección cuantitativa. Para obtener el estado nutricional se aplicará la técnica de análisis documental, el instrumento de

recolección de datos es un cuestionario elaborado y validado por Rodríguez en su investigación²⁸.

4.3.2. Instrumento:

Instrumento 1: Para poder medir la variable uno, se utilizará la técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario elaborado y validado por Rodríguez en el año 2024 en Lima – Perú. La investigación mide sobre: “Conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva”, que Consta de cuatro partes: presentación, instrucciones, datos generales (de la madre y del niño) y datos específicos, dentro del último se abarcaron ambas dimensiones: aspectos generales y técnica de amamantamiento. Se consideraron 20 preguntas de opción múltiple, de las cuales 2 de ellas con imágenes en las alternativas²⁸. **(ANEXO A)**

Para la aplicación del cuestionario se realizará en el servicio de CRED, al terminar la atención, a través de llamadas telefónicas y visitas domiciliarias, previamente coordinadas. Por cada respuesta correcta se obtiene 1 punto, mientras que por cada incorrecta se obtiene 0, teniendo como puntaje final un rango de 0 a 20. Con el valor final alto, medio y bajo. Se valorará de la siguiente manera:

General:

- **Alto (14 -20)**
- **Medio (7-13)**
- **Bajo (0-6)²⁸.**

Para las dimensiones:

- **Aspectos generales:** Alto (07-09), Medio (04-06) y Bajo (0-03)

- **Técnica de amamantamiento:** Alto (08-11), Medio (04-07) y Bajo (0-03)

Instrumento 2: Para la segunda variable, el carné de atención integral de la Niña, Niño y Adolescente de la “NTS N° 137 – MINSA/ 2017/ DGIESP Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño Menor de Cinco Años.”, elaborado por el Ministerio de Salud, donde verificaremos el peso y talla del niño y se evaluara su estado nutricional²⁶. **(ANEXO B)**

Validez y confiabilidad:

Instrumento 1:

El cuestionario fue sometido a validez de contenido según Hernández –Nieto, que permitió que los jueces expertos valoraran cada ítem, estuvo conformado por 4 profesionales especialistas en el tema de investigación, para revisar el constructo y contenido del instrumento. Entre ellos se encuentran 2 metodólogos, 1 especialista en pediatría y 1 en neonatología. Dichos resultados fueron validados a través del Coeficiente de Validez de Contenido, donde se obtuvo como resultado 0,8797 lo que se considera como bueno, y esto indica que el instrumento es aplicable. ²⁸. **(ANEXO C)**

Instrumento 2:

Para la variable dos de estado nutricional no se necesita validez, ya que se utilizará el instrumento validado por el Ministerio de Salud es “NTS N° 137 – MINSA/ 2017/ DGIESP Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño Menor de Cinco Años.” ²⁶.

Asimismo, la fiabilidad no es requerida en esta segunda variable, ya que el dispositivo ha sido previamente estructurado y aprobado por el Ministerio de Salud bajo la misma normativa mencionada.

4.4 Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información:

Los datos obtenidos serán revisados, codificados e incorporados en la base de datos al programa SPSS 26, los resultados obtenidos serán presentados en tablas y gráficos, cada una de ellas con sus respectivas interpretaciones de acuerdo a la variable y con sus respectivas dimensiones.

4.5 Aspectos éticos:

Se tomará en cuenta los aspectos de protección de participantes y los principios bioéticos, además de la autorización de la USMP, así como la aprobación por el comité de ética de la FOE. Esta tesis cumplirá con los cuatro principios bioéticos de investigación.

- **Autonomía:** Los pacientes decidirán voluntariamente a participar de la investigación, se les otorgará un consentimiento informado. **(ANEXO D)**
- **Beneficencia:** Se les explicará a los pacientes sobre los beneficios indirectos que se obtendrá con los resultados de dicho estudio. Estos permitirán determinar la relación del nivel de conocimiento de las madres sobre lactancia materna exclusiva y el estado nutricional de los lactantes menores de 6 meses y en función al tipo de resultado poder identificar la influencia de lactancia materna exclusiva en el estado nutricional del lactante para una posible mejora de dicho problema.
- **No maleficencia:** El instrumento a emplear es un cuestionario previamente evaluado por expertos, que no genera riesgo a la salud de los pacientes.

- **Justicia:** El cuestionario será aplicado a los pacientes con el debido respeto y con absoluta imparcialidad; además, se les explicará el correcto llenado de las mismas.

Declaración de Helsinki:

- **Principios generales:** La investigación estará sujeta a normas éticas que sirven para promover y asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales.
- **Privacidad y confidencialidad:** Se tomarán todas las clases de precauciones para resguardar la intimidad de los sujetos de estudio, participantes de la investigación, así mismo se resguardará la confidencialidad de su información personal.
- **Consentimiento informado:** Se aplicará el estudio de investigación de previo consentimiento, toda persona que acepte ser parte del estudio lo hará libremente, de forma voluntaria y previamente informados. Todas las personas que participan en la investigación tendrán la opción de ser informadas sobre los resultados generales del estudio.
- **Inscripción y publicación de la investigación y difusión de resultados:** Como investigadoras se tendrá la obligación ética con respecto a la publicación y difusión de resultados de la investigación, por lo tanto, se tomará responsabilidad de la integridad y exactitud del informe de resultados.

CRONOGRAMA

N°	ACTIVIDADES	MESES 2025-2026									
		M	J	J	A	S	O	N	D	E	
1.	Identificación y formulación del problema										
2.	Revisión de las fuentes de información										
3.	Redacción de objetivos y operacionalización de las variables										
4.	Determinación del diseño de investigación										
5.	Determinación del marco muestral										
6.	Selección de los estadígrafos a utilizar										
7.	Recolección de datos										
8.	Organización y procesamiento de los datos										
9.	Análisis e interpretación de los resultados										
10	Redacción del informe										
11	Presentación del informe										

PRESUPUESTO

TIPO	SERVICIOS	UNIDAD	COSTO UNIDAD	MONTO TOTAL
Recursos humanos	Personal para la tabulación	30 horas	30	900.00
	Análisis estadístico	10 horas	100	1,000.00
	Traducción del documento en ingles	50 hojas	20	1,000.00
	Sub total	90 horas	150	2,900.00
Adquisición de bienes	Material de escritorio (hojas, tóner de impresión, lapicero)			
	Sub total		630.00	630.00
Servicios	Internet	3 meses	180.00	180.00
	Impresión de cuestionarios y fotocopia de documentos		580.00	580.00
	Movilidad		300.00	300.00
	Sub total			
Total, general				4,590.00

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Organización Mundial de la Salud: Alimentación del lactante y del niño pequeño. [Internet] Ginebra: OMS; 2023 [citado el 15 abril de 2025]. Disponible de:
<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding>
2. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Más del 50% de niños y niñas recién nacidos de todo el mundo no reciben lactancia, lo que incrementa su posibilidad de padecer malnutrición [Internet]. Lima – Perú: UNICEF; 2023 [citado el 15 abril de 2025]. Disponible de:
<https://www.unicef.org/peru/comunicados-prensa/situacion-lactancia-materna-ninos-recien-nacidos-problemas-malnutricion-anemia-obesidad-sobrepeso>
3. Martìn J. Recomendaciones sobre lactancia materna del Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría. [Internet] ;2012. [citado el 15 abril de 2025].16p. Disponible de:
<https://www.aeped.es/comite-nutricion-y-lactancia-materna/lactancia-materna/documentos/recomendaciones-sobre-lactancia-materna>
4. OPS. Lactancia materna y alimentación complementaria. [Internet]. OMS; 2021 [citado el 15 abril de 2025]. Disponible de:
<https://www.paho.org/es/temas/lactancia-materna-alimentacion-complementaria#:~:text=Alrededor%20del%2055%25,Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe>

5. Ministerio de Salud: Información institucional. El 65,9 % de menores de seis meses cuenta con lactancia materna exclusiva. [Internet]. Lima: Gobierno del Perú; 2024 [citado el 15 abril de 2025]. Disponible de: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/1021904-el-65-9-de-menores-de-seis-meses-cuenta-con-lactancia-materna-exclusiva>
6. Organización Mundial de la Salud: Crecimiento Infantil [Internet]. OMS; 2025 [citado el 15 abril de 2025]. Disponible de: https://www.who.int/es/health-topics/child-growth#tab=tab_1
7. OMS: Estándares de crecimiento infantil [Internet]. OMS; 2025 [citado el 15 mayo de 2025]. Disponible de: <https://www.who.int/tools/child-growth-standards/standards>
8. Salazar Calderón E, Zentner Aristas J , Sosa Flores J, et al. Asociación entre la adherencia de las madres a la lactancia materna exclusiva y el estado nutricional de sus hijos, evaluados en tres centros de salud. Rev. Exp. Med. [Internet]. 2021 [citado 15 mayo de 2025];6(4): 63 - 78. Disponible de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9034817>
9. Biscontin, T. Teoría del logro del rol materno. [Internet]. 2023 [citado 15 de mayo de 2025] Disponible de: <https://www.ebsco.com/research-starters/psychology/maternal-role-attainment-theory>
10. Pacto Mundial. Red Española. 17 objetivos de Desarrollo para transformar el mundo. [Internet]. 2022 [citado el 15 mayo de 2025]. Disponible de: <https://www.pactomundial.org/que-puedes-hacer-tu/ods/>
11. Unicef: Sólo 4 de cada 10 bebés menores de 6 meses son exclusivamente amamantados en América Latina y el Caribe [Internet]. Lima: Gobierno del Perú; 2023 [citado el 15 mayo de 2025]. Disponible de:

<https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/solo-4-cada-10-bebes-menores-6-meses-exclusivamente-amamantados-america-latina-caribe-semana-lactancia-materna>

12. Díaz Fuentes K. Conocimiento de la lactancia materna en madres de puerperio mediato relacionado al estado nutricional del recién nacido en el Hospital San Francisco de Quito [tesis de maestría en salud pública en Internet]. Ecuador: Universidad Técnica del Norte, 2021 [citado el 15 de junio de 2025]. 69 p. Disponible de: http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/11993/2/PG_1014_TRABAJO_GRADO.pdf
13. Méndez N. Conocimiento, práctica correcta del amamantamiento y nutrición en lactantes menores de 6 meses. 2023 [citado el 15 de junio de 2025]. Disponible de: https://iydt.wordpress.com/wp-content/uploads/2023/05/3_11_conocimiento-practica-correcta-del-amamantamiento-y-nutricion-en-lactantes-menores-de-6-meses-1.pdf
14. Zapata Mejía E. Conocimiento sobre lactancia materna en madres y estado nutricional de los niños menores de 6 meses en un centro de salud materno infantil nacional, Trujillo [tesis de pregrado en Internet]. Trujillo: Universidad Mayor de San Marcos, 2022 [citado el 15 junio de 2025]. 67 p. Disponible de: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNMS_aff9e1c5ee9d53075d29316eb7c7dbaa
15. Romero Mendoza K. Lactancia materna exclusiva y estado nutricional de niños menores de 6 meses que son atendidos en el consultorio de crecimiento y desarrollo en un centro de salud de Lima [tesis de pregrado en Internet]. Perú: Universidad Norbert Wiener, 2023 [citado el 15 de junio de

- 2025]. 84 p. Disponible de:
https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/10324/T061_43463277_T.pdf?sequence=11&isAllowed=y
16. Cañarte J. Espinoza M. Pin A. Revisión sistemática sobre la teoría del conocimiento y la epistemología en la administración en salud. Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas. [Internet]. 2021 [citado 15 de junio de 2025];14(1):116-130. Disponible de:
[file:///C:/Users/RUBY/Downloads/Dialnet-RevisionSistemicaSobreLaTeoriaDelConocimientoYLa-8590396%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/RUBY/Downloads/Dialnet-RevisionSistemicaSobreLaTeoriaDelConocimientoYLa-8590396%20(3).pdf)
17. Morales S. Recordemos lo importante que es la lactancia en México [Internet]. Rev. Fac. Med. [Internet]. 2022 [citado 15 de junio de 2025];65(2). Disponible de:
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422022000200003
18. Organización Mundial de la Salud. Lactancia Materna [Internet]. OMS ;2025 [citado el 15 de junio de 2025]. Disponible de:
https://www.who.int/es/health-topics/breastfeeding#tab=tab_1
19. Hernández A. Conocimientos de madres y padres sobre lactancia materna exclusiva. Medisan. [Internet].2023. [citado el 20 de junio de 2025];27(2). Disponible de:
<https://www.redalyc.org/journal/3684/368475187001/html/>
20. Perú. Ministerio de Salud. Guía técnica para la consejería en lactancia materna. Resolución Ministerial N° 462-2015/MINSA (2019)

21. Orna J, Fiallos J, Romero E. Impacto de la Composición Química de la leche Materna en el Desarrollo Cognitivo durante la Infancia. *Mediciencia Uta*. [Internet]. 2024. [citado el 20 de junio de 2025];8(3): 76-81. Disponible de: <https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/medi/article/view/2515/2992b>
22. Servicio Canario de la Salud. Protocolo para la alimentación materna en el primer ciclo de educación infantil. [Internet]. 2024 [citado el 20 de junio de 2025]. Disponible de: <https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=86c8aef2-a967-11e1-a270-87db0c674047&idCarpeta=d75b1327-98dd-11e1-9f91-93f3670883b5>
23. Bajaan V, Lainez Y, Solorzano E. Lactancia Materna Exclusiva, Ecuador [Tesis de pregrado en Internet]. Ecuador: Universidad de Especialidades Espíritu Santo, 2025 [citado el 20 de junio del 2025]. 14 p. Disponible de: <https://www.studocu.com/ec/document/universidad-de-especialidades-espiritu-santo/pediatrica/informe-1-lactancia-materna-exclusiva/122969719>
24. Unicef: Posturas y posiciones para amamantar. [Internet]. Lima: Gobierno del Perú; 2023 [citado el 20 de junio de 2025]. Disponible de: <https://www.unicef.org/uruguay/crianza/primeros-anos/posturas-y-posiciones-para-amamantar>
25. Perú. Guía Técnica para la Valoración Nutricional Antropométrica de la niña y el Niño de 0 A 11 años. Resolución Ministerial RM-034-2024-Minsa
26. Perú. Técnica de salud para el control del crecimiento y desarrollo de la niña y el niño menor de cinco años. Resolución Ministerial N.º 990 - 2010/MINSA (2011 Jun)

27. Perú. Colegio de Enfermeras del Perú. Ley del Trabajo de la Enfermera(o) N°27669. 2002.

28. Rodríguez Vela S. Nivel de conocimientos sobre Lactancia Materna

Exclusiva en madres que acuden a un Centro de Salud, Lima. [tesis de pregrado en Internet]. Perú: Universidad Mayor de San Marcos, 2024 [citado el 20 de junio de 2025]. 94 p. Disponible de:

<https://cybertesis.unmsm.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/1010a906-bfbb-48fd-b6f2-5a7775f221ff/content>

ANEXOS

ANEXO A: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

INSTRUMENTO N° 1

CUESTIONARIO: NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA QUE ACUDEN AL SERVICIO DE CRED EN EL C.S DE JESÙS MARÌA. 2025

I.- PRESENTACIÒN:

Buenos días, somos Rosa Albertina Mendoza Álvarez y Gladys Ruby León Dávila, estudiantes de la carrera profesional de Enfermería de la USMP, el presente cuestionario tiene como objetivo: Determinar los conocimientos de las madres sobre la lactancia materna exclusiva que acuden al Centro de Salud de Jesús María, para lo cual solicito su colaboración a través de sus respuestas sinceras: la información será confidencial. Agradezco anticipadamente su participación. Gracias

A. DATOS GENERALES:

De la madre:

1. Edad: 18 – 23 años (A)
 24 – 29 años (B)
 30 – 35 años (C)
 36 años a más (D)

2. Grado de Instrucción:

Ninguno (A)

Primaria(B)

Secundaria (C)

Técnica (D)

Universitaria (E)

3. Estado Civil:

Casada (A)

Soltera(B)

Conviviente (C)

Viuda (D)

Divorciada (E)

4. Ocupación:

Ama de casa (A)

Trabaja (B)

5. Números de hijos en total:

1(A)

2(B)

3(C)

4 ó más (D)

Del bebé:

1.-Edad del Niño:

- (A) 0 días a 1 mes
- (B) 1 mes 1 día a 2 meses
- (C) 2 meses 1 día a 3 meses
- (D) 3 meses 1 día a 4 meses
- (E) 4 meses 1 día a 5 meses
- (F) 5 meses 1 día a 6 meses

2.-Sexo:

Femenino (A)

Masculino (B)

B.-DATOS ESPECIFICOS:

A continuación, marque con un aspa(x) las respuestas a las siguientes preguntas que presentan opción múltiple, es importante que solo marque una alternativa.

1.La lactancia materna exclusiva consiste en darle al niño(a):

- a. Leche materna y papilla
- b. leche materna y sopas
- c. Leche materna y agua
- d. Solo leche materna

2.La lactancia materna exclusiva se brinda al niño (a) hasta los primeros:

- a. 2 meses de vida.
- b. 3 meses de vida.
- c. 6 meses de vida.
- d. 5 meses de vida.

3.La lactancia materna se inicia por primera vez:

- a. Después de 2 horas de nacimiento
- b. Durante la primera hora de vida
- c. Un día después del nacimiento
- d. Después de 3 horas de nacimiento

4.La primera leche producida por la madre es conocida como calostro,la cual ayuda al bebé en:

- a. La eliminación del meconio (primera deposición)
- b. Elevar el sistema inmunológico
- c. Qué acepte más rápido la leche materna
- d. Generar un mayor vínculo con su madre

5.La lactancia materna exclusiva es importante porque:

- a. Es una de las formas para alimentar al niño(a) junto a la fórmula láctea
- b. Brinda los nutrientes esenciales y la hidratación necesaria para su óptimo desarrollo
- c. Lo alimenta por 1 año entero sin necesidad de brindar otros alimentos
- d. Lo ayuda solo a su crecimiento físico

6.Los tipos de leche materna que existen son.

- a. Calostro y leche madura
- b. Leche de transición y leche madura
- c. Calostro y leche de transición
- d. Calostro, leche de transición y leche madura

7. Los beneficios que brinda la lactancia materna exclusiva al niño(a)

- a. Favorece su adecuado crecimiento y desarrollo y lo protege de enfermedades crónicas
- b. Fortalece solo su sistema excretor y es gratis
- c. Favorece el vínculo padre-hijo y reduce el riesgo de sufrir osteoporosis
- d. Duerme con más rapidez, más tiempo y permite a la madre realizar otras actividades.

8. Los beneficios que brinda la lactancia materna exclusiva a la madre son:

- a. Ayuda en la recuperación después del parto y disminuye la posibilidad de contraer enfermedades crónicas no transmisibles
- b. Sirve como anticonceptivo natural y contribuye con la involución más rápida del útero
- c. Reduce la incidencia de hemorragias postparto y ayuda a la subida del peso corporal
- d. Es gratis y ayuda a la prevención del cáncer de estómago

9. Los beneficios que brinda la lactancia materna exclusiva a la familia

además de ser económica, permite:

- a. Reducir el riesgo de padecer VIH
- b. Su disponibilidad inmediata
- c. Disminuye la muerte de niños(as) menores de 2 años
- d. No contaminar el medio ambiente

10. Antes de dar de lactar, lo primero que usted tiene que hacer como medida higiénica es:

- a. Amarrarse el cabello
- b. Bañarse
- c. Cambiarse de ropa
- d. Lavarse las manos con agua y jabón

11.El reflejo de búsqueda se refiere cuando el niño(a):

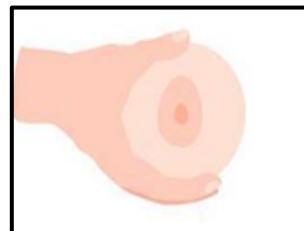
- a. Lleva su mano a la boca
- b. Mueve la cabeza y abre la boca para buscar en dirección al seno de la madre
- c. Siente que se toca la palma de la mano y la cierra inmediatamente
- d. Se ríe al tocarle suavemente las mejillas

12.Cuando se da de lactar al niño, la madre debe coger su seno en forma de:

a)



b)



13. La posición que debe adoptar la madre al amantar además de ser cómoda y relajada, debe colocar la cabeza del niño sobre:

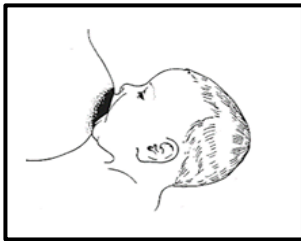
- a. La flexión de su codo
- b. El antebrazo
- c. Todo el brazo
- d. Las piernas

14. La posición que un niño(a) debe optar cuando es amantado, además de estar pegado a la madre, debe coger con su boca:

- a. La mitad del pezón
- b. El pezón y gran parte de la areola
- c. La punta del pezón
- d. Toda la areola

15. Marque la imagen que Ud. considere que tiene un buen agarre del seno materno:

a)



B)



16. La succión del niño (a) es considerada adecuada, cuando las mamadas son:

- a. Lentas, profundas y con pausas cortas
- b. Rápidas, profundas y con pausas prolongadas
- c. Lentas, superficiales y con pausas prolongadas
- d. Rápidas, profundas y sin pausas

17. Una succión adecuada también se puede observar cuando el niño presenta:

- a. Mejillas tensas, mentón del bebé en el aire y labio inferior invertido
- b. Labio inferior invertido, mentón del bebé tocando el seno materno y boca media abierta
- c. Labio inferior invertido, mejillas redondeadas y boca bien abierta
- d. Mejillas redondeadas, mentón del bebé en el aire y el labio inferior e vertido

18. Cuando el niño no tiene un buen agarre, los senos de la madre

pueden sufrir:

- a. Abultamiento de leche materna
- b. Raspones en todo el seno materno
- c. Grietas o heridas en el pezón
- d. Moretones alrededores del pezón
- e. Vaciamiento de leche materna

19. Se debe amantar al niño(a) de cada: rango de tiempo)

- a. 3 a 5 minutos
- b. 20 a 30 minutos
- c. 2 a 3 horas
- d. 5 a 6 horas

20. Se debe amantar al niño(a) cada vez que: (situación o momento)

- a. Lloro
- b. Se despierta
- c. No hay momento determinado (libre demanda)
- d. Realiza un quejido

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN!

ANEXO B: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS N° 2

HOJA DE REGISTRO DE DATOS: ESTADO NUTRICIONAL DE LOS LACTANTES MENORES DE 6 MESES QUE ACUDEN AL SERVICIO DE CRED EN EL C.S. DE JESÚS MARÍA. 2025

1) SOMATOMETRÍA DEL LACTANTE

EDAD:

PESO:

TALLA:

2) ESTADO NUTRICIONAL:

P/E

- ☐ Sobrepeso
- ☐ Normal
- ☐ Bajo peso
- ☐ Bajo peso severo

P/T

- ☐ Obesidad
- ☐ Sobrepeso
- ☐ Normal
- ☐ Desnutrición Aguda
- ☐ Desnutrición Severa

T/E

- ☐ Muy alto
- ☐ Alto
- ☐ Normal
- ☐ Talla baja
- ☐ Talla baja severa

ANEXO C: INFORME DE JUICIOS EXPERTOS

COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO (CVC)

Item	J1	J2	J3	J4	Σ	Mx	CVCi	Pei	CVCic
1	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
2	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
3	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
4	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
5	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
6	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
7	4	4	5	3	16	4,0000	0,8000	0,0039	0,7961
8	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
9	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
10	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
11	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
12	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
13	3	4	5	5	17	4,2500	0,8500	0,0039	0,8461
14	4	4	5	4	17	4,2500	0,8500	0,0039	0,8461
15	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
16	4	4	5	4	17	4,2500	0,8500	0,0039	0,8461
17	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
18	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
19	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
20	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
								TOTAL	17,6719
								CVCi	0,88358375
								CVCic	0,8797

INTERPRETACIÓN DEL CÁLCULO DEL CVC

Valor del CVC	Interpretación de la validez y concordancia
De 0 a 0,60	Inaceptable
Mayor a 0,60 y menor o igual a 0,70	Deficiente
Mayor a 0,70 y menor o igual a 0,80	Aceptable
Mayor a 0,80 y menor o igual a 0,90	Buena
Mayor a 0,90	Excelente

Fuente: Hernández-Nieto (2011)

Interpretación: Se encuentra entre 0.80 y 0.90, lo que es considerado como buena, por lo que el instrumento es válido para aplicación.

ANEXO D: CONSENTIMIENTO INFORMADO

CONSENTIMIENTO INFORMADO

El presente trabajo de investigación que tiene como título “NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS LACTANTES MENORES DE 6 MESES QUE ACUDEN AL SERVICIO DE CRED EN EL C.S. DE JESÚS MARÍA.2025”, desarrollado por las estudiantes Rosa Mendoza Álvarez y Ruby León Dávila de la Universidad USMP de la carrera de Enfermería. La información que usted nos brindará, será confidencial, pues solo las investigadoras tendrán acceso a esta información, por tanto, estará protegida. La aplicación del instrumento tiene una duración aprox de 20 min y consiste en un cuestionario de 14 preguntas, que nos ayudará a saber si existe relación entre el conocimiento de la lactancia materna exclusiva y el estado nutricional del niño. Su participación es voluntaria y sus respuestas solo serán utilizadas con fines de la investigación guardándose el anonimato en todo momento.

Por lo mencionado anteriormente, si usted está de acuerdo con participar en esta investigación proceda a firmar el consentimiento informado.

Firma del participante

DNI:

ANEXO E: MATRIZ DE CONSISTENCIA

TÍTULO DEL PROYECTO: “NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y EL ESTADO NUTRICIONAL DEL LACTANTES MENORES DE 6 MESES QUE ACUDEN AL SERVICIO DE CRED EN EL C.S. DE JESÚS MARÍA. 2025”

AUTORES:

- Rosa Albertina Mendoza Álvarez
- Gladys Ruby León Dávila

PROBLEMAS	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	METODOLOGÍA
PROBLEMA PRINCIPAL ¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento de las madres sobre lactancia materna exclusiva y el estado nutricional de los lactantes menores de 6 meses que acuden al servicio de CRED en el C.S. Jesús María.2025?	OBJETIVO GENERAL Determinar la relación entre el nivel de conocimiento de las madres sobre lactancia materna exclusiva y el estado nutricional de los lactantes menores de 6 meses atendidos en el servicio de CRED del C.S. de Jesús María. 2025	HIPÓTESIS GENERAL Hi: “Existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento de las madres sobre la lactancia materna exclusiva y el estado nutricional de los lactantes menores de 6	V1: NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA D1: Aspectos generales	Enfoque: Cuantitativo Tipo de investigación: Descriptivo – correlacional, de corte transversal y prospectivo Diseño: No experimental. Población: 256 Muestra: 153 Tipo de Muestra: Probabilístico (aleatoria) $n = (1.96)^2 (0.5) (0.5) (256)$ $(0.05)^2 (256-1) + (1.96)^2 (0.5) (0.5)$ $N = 153$ Criterios de Inclusión:

PROBLEMAS SECUNDARIOS - ¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento de las madres sobre lactancia materna y el patrón de crecimiento Peso/edad, de lactantes menores de 6 meses? - ¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento de las madres sobre lactancia materna y el patrón de crecimiento Talla/Edad de lactantes menores de 6 meses? - ¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento de las madres sobre lactancia materna y el patrón de crecimiento del Peso/Talla de lactantes menores de 6 meses?	OBJETIVOS ESPECÍFICOS -Establecer la relación entre nivel de conocimiento de las madres sobre lactancia materna y el patrón de crecimiento Peso/edad en los lactantes menores de 6 meses. - Establecer la relación entre nivel de conocimiento de las madres sobre lactancia materna y el patrón del crecimiento Talla/Edad de lactantes menores en lactantes menores de 6 meses. - Establecer la relación entre nivel de conocimiento de las madres sobre lactancia materna y el patrón de crecimiento Peso/Talla en lactantes menores de 6 meses.	meses atendidos en el servicio de CRED del Centro de Salud Jesús María.2025 Ho: “No existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento de las madres sobre la lactancia materna exclusiva y el estado nutricional de los lactantes menores de 6 meses atendidos en el servicio de CRED del Centro de Salud Jesús María. 2025	D2. Técnica de amamantamiento V2: ESTADO NUTRICIONAL DE LOS LACTANTES MENORES DE 06 MESES D1: P/E D2:P/T D3: T/ E	• Madres de lactantes de 0 a 6 meses. • Madres de lactantes que se atienden en el Centro de Salud de Jesús María. • Lactantes evaluados en CRED • Madres de lactantes con Lactancia Materna Exclusiva. • Madres que han otorgado su consentimiento informado. Criterios de Exclusión: • Madres de niños mayores de 6 meses. • Madres de lactantes que no se atienden en el Centro de Salud de Jesús María. • Lactantes no evaluados en CRED. • Madres que no practican la Lactancia Materna Exclusiva. • Madres que no han suscrito el consentimiento informado. V1: Técnica: Encuesta Instrumento: Cuestionario V2: Técnica: Observación Instrumento: Hoja de registro de datos
---	--	--	---	--

ANEXO F: POBLACIÓN Y MUESTRA

$$n = \frac{(1.96)^2 (0.5) (0.5) (256)}{(0.05)^2 (256-1) + (1.96)^2 (0.5) (0.5)}$$

$$n = \frac{245,8624}{1,5979}$$

$$n = 153$$